

Ictère

Anamnèse

1. Caractériser l'ictère
 - a. Début
 - b. Contexte d'apparition
 - c. Localisation
 - d. Facteurs aggravants
 - e. Facteurs atténuants
 - f. Constant vs fluctuant
 - g. Symptômes associés
 - h. 1^{er} épisode vs récurrent**
2. Anamnèse générale
 - a. Perte de poids
 - b. Fièvre
 - c. Frissons
 - d. Sudations nocturnes
3. Anamnèse digestive
 - a. Douleur abdominale (caractériser si oui)
 - b. Nausée et vomissement
 - c. Dysphagie
 - d. Selles
 - i. Fréquence
 - ii. Sang
 - iii. Couleur**
4. **DD hépatites**
 - a. Vaccin hépatite A et B**
 - b. Voyage dans les zones endémiques**
 - c. Drogues IV**
 - d. Rapports sexuels à risque**
 - e. Tatouage récent, piercing**
5. Anamnèse urogénitale
 - a. Couleur des urines**
 - b. Sang dans les urines
 - c. Dernières règles
6. Antécédents personnels
 - a. Maladie
 - b. Médicaments
 - c. Chirurgie
 - d. Hospitalisation
 - e. Allergies
7. Antécédents familiaux
8. Habitudes alimentaires

Examen clinique

1. Préparation du status
 - a. Position de l'étudiant à D
 - b. Jambes et bras décroisés, le long du corps
 - c. Tête du patient surélevée
2. Regarder les sclères
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimité la taille du foie
5. Palpation des (**!!! maintenir contact visuel**)
 - a. Superficiel
 - i. 4 quadrants
 - b. Palpation profonde
 - i. 4 quadrants
 - ii. Rate
 - iii. Reins
 - iv. Foie
 - c. Défense et détente
 - d. **Murphy**

DD

- **Néoplasie des voies biliaires**
- *Cholangite = inflammation que du cholédoque (fièvre, douleur : murphy +)*
- *Angiocholite = inflammation de toutes les voies biliaires (fièvre 39.5, frissons, douleur hypochondre D, secondairement à obstruction des voies biliaires)*
- **Choléchodocholithiase**
- **Hépatite** (douleur hypochondre D)
- **Pancréatite chronique** (douleurs irradiant dans le dos, épisodes à répétition, intensité augmente)
- **Carcinome pancréatique**
- **Hémolyse**
 - o *Malaria (fatigue, fièvre, hémolyse)*
 - o *Auto-immun (héماغلوتينine froide, héماغلوتينine chaude)*
 - o *Allo-immun (, incompatibilité ABO, rhésus)*
 - o *Thalassémie*
 - o *Déficit G6PD*

Examen complémentaire :

- CRP
- Crase
- Bilan hépatique, lipase
- LDH, haptoglobine
- Coombs si suspicion hémolyse

Bilirubine :

- *Bilirubine conjuguée : obstruction, foie*
- *Bilirubine non conjuguée : hémolyse*